

Torsion Testiculaire : Une Urgence Urologique Absolue

Durée : 25 minutes

Niveau : Étudiant en médecine (externat), Interne, Médecin généraliste

Mots-clés : Torsion testiculaire, Scrotum aigu, Urgence urologique, Douleur testiculaire, Signe de Prehn, Réflexe crémastérien

Objectifs Pédagogiques

- Définir la torsion testiculaire et reconnaître son caractère d'urgence absolue.
- Identifier les populations à risque et les facteurs prédisposants.
- Expliquer la physiopathologie et l'importance critique du facteur temps.
- Maîtriser les éléments clés de l'anamnèse et de l'examen clinique.
- Connaître la place et les limites des examens complémentaires, notamment l'écho-Doppler.
- Énumérer les principaux diagnostics différentiels du scrotum aigu.
- Décrire la prise en charge thérapeutique en urgence, de l'arrivée du patient à la chirurgie.
- Comprendre les principes de l'intervention chirurgicale (détorsion, orchidopexie, orchidectomie).

Introduction et Contexte Scientifique

La torsion testiculaire est une urgence chirurgicale urologique due à la rotation du cordon spermatique, entraînant une strangulation vasculaire et une ischémie du testicule.

Elle touche principalement les adolescents et les jeunes adultes. Le symptôme cardinal est une douleur scrotale aiguë, unilatérale et d'apparition brutale, souvent accompagnée de nausées et vomissements.

Le diagnostic est avant tout clinique, reposant sur des signes évocateurs comme l'ascension du testicule et l'abolition du réflexe crémastérien. L'adage 'Le temps, c'est du testicule' souligne l'extrême urgence de la situation : la viabilité du testicule est compromise au-delà de 6 heures.

La prise en charge impose un avis urologique immédiat pour une exploration chirurgicale sans délai. Le traitement consiste en une détorsion et une fixation des deux testicules (orchidopexie) pour prévenir toute récurrence.

Contexte et épidémiologie

Définition

La torsion testiculaire est la rotation axiale du cordon spermatique, qui contient les vaisseaux (artères et veines) irriguant le testicule. Cette rotation entraîne une interruption du flux sanguin, provoquant une ischémie aiguë qui, sans intervention rapide, mène à la nécrose et à la perte du testicule.

Une urgence urologique absolue

C'est l'une des urgences les plus critiques en urologie. Chaque minute compte pour la survie du testicule.

Épidémiologie

- **Incidence** : Environ 1 cas pour 4000 hommes de moins de 25 ans par an.
- **Distribution par âge** : On observe deux pics de fréquence :
 1. **Période néonatale** (torsion extravaginale, où tout le complexe testicule-vaginale se tord).
 2. **Puberté et adolescence (12-18 ans)** : C'est le pic principal. La croissance rapide du testicule à la puberté le rend plus mobile et susceptible de se tordre.

Facteurs de risque

Le principal facteur est une anomalie anatomique de la fixation du testicule, appelée **malformation en 'battant de cloche'** (bell clapper deformity). Normalement, le testicule est fixé à la paroi scrotale postérieurement. Dans cette malformation, il est suspendu librement dans la vaginale, comme un battant dans une cloche, ce qui lui permet de tourner sur son axe.

Autres facteurs :

- Antécédent de torsion intermittente (épisodes de douleur résolutifs).
- Antécédent de cryptorchidie (testicule non descendu).
- Traumatisme scrotal récent.
- Effort physique intense ou survenant au repos/pendant le sommeil (contraction du muscle crémaster).

Physiopathologie

La torsion du cordon spermatique déclenche une cascade d'événements vasculaires :

1. **Obstruction veineuse** : Les veines, à paroi plus fine, sont comprimées en premier. Le sang artériel continue d'arriver, mais le retour veineux est bloqué. Cela provoque une stase veineuse, une congestion, un œdème et une hémorragie intratesticulaire.
2. **Obstruction artérielle** : L'augmentation de la pression intratesticulaire finit par dépasser la pression artérielle, entraînant l'arrêt complet du flux sanguin artériel. C'est le début de l'ischémie.
3. **Infarctus et nécrose** : L'ischémie prolongée conduit à une nécrose irréversible du parenchyme testiculaire.

La course contre la montre : "Le temps, c'est du testicule"

La viabilité du testicule dépend directement du délai entre le début des symptômes et la détorsion chirurgicale :

- **< 6 heures** : Taux de sauvetage du testicule > 90%.
- **Entre 6 et 12 heures** : Taux de sauvetage d'environ 50%.
- **Entre 12 et 24 heures** : Taux de sauvetage de 10-20%.
- **> 24 heures** : Sauvetage exceptionnel (< 10%).

Ce facteur temps justifie que tout doute diagnostique impose une exploration chirurgicale en urgence.

Tableau clinique

Le diagnostic de la torsion testiculaire est **essentiellement clinique**.

Anamnèse

- **Douleur** : Le maître symptôme. Elle est typiquement :
- **Brutale** : "en coup de tonnerre dans un ciel serein".
- **Unilatérale**.
- **Très intense**, voire insupportable.

- **Continue**, sans position antalgique.
- Avec une **irradiation** possible vers la région inguinale, le flanc ou l'abdomen (peut mimer une urgence abdominale).
- **Signes associés** : Nausées et vomissements sont très fréquents (réflexe vagal).
- **Contexte** : Souvent nocturne, réveillant le patient.
- **Antécédents** : Il faut rechercher des épisodes similaires plus brefs et spontanément résolutifs (torsion-détorsion).

Examen physique

- **Inspection** : Le scrotum du côté atteint est inflammatoire : rouge, œdématisé.
- **Palpation (comparative)** :
 - Le testicule atteint est **extrêmement douloureux**.
 - Il est souvent **ascensionné** dans la bourse, tiré vers le haut par le cordon spermatique raccourci et tordu.
 - Il peut être **horizontalisé** (position en "battant de cloche").
- **Signes cliniques clés** :
 - **Abolition du réflexe crémasterien** : C'est le signe le plus sensible. On stimule la face supéro-interne de la cuisse ; l'absence d'ascension du testicule homolatéral est très évocatrice de torsion. (Sensibilité proche de 100%).
 - **Signe de Prehn négatif** : Le soulèvement du testicule n'améliore pas, voire aggrave, la douleur (contrairement à l'orchi-épididymite où il peut la soulager). Ce signe est moins fiable.

Examens complémentaires

Principe fondamental

Aucun examen complémentaire ne doit retarder une exploration chirurgicale si la suspicion clinique de torsion est forte. En cas de doute, on opère.

Écho-Doppler Scrotal

C'est l'examen de choix **UNIQUEMENT** si le diagnostic est incertain et s'il est réalisable dans des délais très courts (immédiatement disponible, radiologue expérimenté).

- **Ce qu'il montre** :
- **Mode Doppler couleur et pulsé** : Met en évidence une **absence de flux sanguin** (artériel et veineux) au sein du parenchyme testiculaire, contrastant avec un flux normal du côté controlatéral.
- **Mode échographique (2D)** : Peut montrer un testicule augmenté de volume, hypoéchogène (signe d'œdème ou de nécrose). L'enroulement du cordon spermatique peut parfois être visualisé ("whirlpool sign").
- **Utilité** : Permet de confirmer le diagnostic et surtout d'aider au diagnostic différentiel (ex: hypervascularisation dans l'orchi-épididymite).

Examens Biologiques

- **Bandelette urinaire / ECBU** : Généralement normaux dans la torsion. Une leucocyturie ou une bactériurie oriente plutôt vers une cause infectieuse (épididymite) mais ne l'élimine pas formellement.
- **Bilan sanguin (NFS, CRP)** : Non spécifique. Peut montrer un syndrome inflammatoire. Utile pour le bilan préopératoire.

Diagnostic différentiel

La torsion testiculaire s'inscrit dans le cadre du **scrotum aigu**. Les principaux diagnostics à écarter sont :

1. Orchi-épididymite aiguë :

- Cause la plus fréquente de scrotum aigu chez l'adulte.

- Douleur d'installation plus progressive.
- Contexte fébrile, signes urinaires (brûlures, pollakiurie) fréquents.
- À l'examen, la douleur prédomine sur l'épididyme (pôle postéro-supérieur du testicule).
- Réflexe crémasterien **présent**.
- Signe de Prehn souvent **positif**.
- Écho-Doppler : **Hypervascularisation** de l'épididyme et/ou du testicule.

2. Torsion d'une hydatide testiculaire (ou de Morgagni) :

- Fréquent chez le garçon prépubère (7-12 ans).
- L'hydatide est un petit reliquat embryonnaire au pôle supérieur du testicule.
- Douleur d'intensité modérée, localisée au pôle supérieur.
- Signe pathognomonique (mais inconstant) : **"Blue dot sign"**, nodule bleuté visible par transparence à travers la peau du scrotum.
- Le traitement est généralement conservateur (repos, AINS).

3. Autres causes plus rares :

- Traumatisme testiculaire avec hématocèle.
- Hernie inguino-scrotale étranglée.
- Tumeur testiculaire nécrosée ou hémorragique.
- Œdème scrotal idiopathique.

Prise en charge

Une urgence thérapeutique

1. Mise en condition aux urgences :

- Patient mis **à jeun** immédiatement.
- Pose d'une **voie veineuse périphérique**.
- **Antalgiques** puissants (palier 3, morphiniques) car la douleur est intense.
- Bilan pré-opératoire.

2. Avis urologique immédiat :

- Contacter l'urologue de garde sans délai. L'indication chirurgicale est posée sur la clinique.

3. Tentative de détorsion manuelle :

- Peut être tentée aux urgences par un médecin expérimenté, en attendant le bloc.
- Le mouvement est une rotation **externe** (comme pour "ouvrir un livre").
- Le succès est marqué par un soulagement immédiat et spectaculaire de la douleur.
- **Attention** : Même en cas de succès, l'exploration chirurgicale reste **obligatoire** pour fixer le testicule et éviter la récurrence.

Traitement Chirurgical : L'Exploration Scrotale

C'est le seul traitement curatif. Elle se déroule sous anesthésie générale.

- **Incision** : Voie d'abord scrotale.
- **Exploration** : Ouverture de la vaginale, extériorisation du testicule et de son cordon.
- **Détorsion** : Le chirurgien détord manuellement le cordon spermatique.
- **Évaluation de la viabilité** : Le testicule est réchauffé avec des compresses chaudes. Le chirurgien évalue son recoloration et sa vitalité. Une petite incision de l'albuginée peut être faite pour vérifier le saignement.
- **Décision thérapeutique** :
- **Si le testicule est viable** : **Orchidopexie**. Le testicule est fixé par des points non résorbables à la paroi interne

du scrotum pour empêcher toute nouvelle rotation.

- **Si le testicule est non viable (nécrosé) : Orchidectomie.** L'ablation du testicule nécrosé est nécessaire pour éviter les complications (douleur chronique, surinfection, réaction auto-immune contre l'autre testicule).
- **Orchidopexie controlatérale systématique :** L'anomalie de fixation étant souvent bilatérale, le testicule controlatéral est **systématiquement fixé** au cours de la même intervention pour le protéger d'une torsion future. C'est un point capital.

Prévention et éducation du patient

Suivi post-opératoire

- Information claire et honnête au patient et à sa famille sur le résultat de l'intervention.
- En cas d'orchidectomie, discuter des options futures : pose d'une **prothèse testiculaire** pour des raisons esthétiques et psychologiques.
- Aborder les questions sur la **fertilité**. La perte d'un testicule n'entraîne généralement pas d'infertilité si le testicule restant est sain, mais une altération de la spermatogenèse est possible même si le testicule a été sauvé.

Prévention

- La seule véritable prévention est **l'orchidopexie controlatérale** réalisée lors de l'intervention initiale.
- Chez les patients présentant des épisodes de **torsion-détorsion intermittente**, une orchidopexie bilatérale élective (programmée) est indiquée pour prévenir un épisode aigu.

Éducation

- Le message clé à faire passer au grand public et aux patients est que **toute douleur testiculaire aiguë et brutale est une torsion jusqu'à preuve du contraire et nécessite une consultation aux urgences sans aucun délai.**

Résumé final

Pour conclure, retenons les points essentiels :

1. **Urgence absolue :** La torsion testiculaire est une course contre la montre. Le pronostic fonctionnel du testicule est en jeu.
2. **Population cible :** Penser systématiquement à ce diagnostic chez un adolescent ou un jeune homme se présentant pour une douleur scrotale aiguë.
3. **Diagnostic clinique :** La triade "douleur scrotale brutale + nausées/vomissements + abolition du réflexe crémastérien" est extrêmement évocatrice.
4. **Pas de retard :** Ne laissez jamais un examen d'imagerie, même un écho-Doppler, retarder une prise en charge chirurgicale si votre suspicion clinique est élevée.
5. **Traitement chirurgical :** L'exploration est la règle. Le but est de détordre et de réaliser une orchidopexie bilatérale. L'orchidectomie est malheureusement nécessaire en cas de nécrose.

Le message à retenir pour votre pratique est simple : devant une douleur testiculaire aiguë, le temps de réflexion doit être minimal et l'appel à l'urologue, immédiat.

Références Bibliographiques

1. Collège Français des Urologues. (2021). Item 120 - Tumeurs du testicule. In **Urologie** (7e éd.). Elsevier Masson.
2. European Association of Urology (EAU). (2022). **Guidelines on Urological Trauma**.
3. Wein, A. J., Kavoussi, L. R., Partin, A. W., & Peters, C. A. (Eds.). (2020). **Campbell-Walsh-Wein Urology** (12th ed.). Elsevier.